BRIEFING/DEFUSING/DEBRIEFING. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

Autores: Grupo de Trabajo MERAKI

Índice

0. INTRODUCCION 1

1. WHY. POR QUÉ ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR BRIEFING, DEFUSING Y DEBRIEFING EN NUESTRO MEDIO 3

2. HOW. CÓMO IMPLEMENTAR LOS BRIEFING, DEFUSING Y DEBRIEFING EN NUESTRO MEDIO. 3

3. WHAT. QUÉ HERRAMIENTAS Y RECURSOS SON NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS BRIEFING, DEFUSING Y DEBRIEFING EN NUESTRO MEDIO 8

0. INTRODUCCIÓN

El presente documento habla del Briefing/Defusing/Debriefing (BDD) en el contexto de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias para la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia.

Una situación de emergencia en contexto extrahospitalario, es un escenario complejo que el equipo sanitario afronta, y que presenta ciertas particularidades:

- Puede abordarse desde distintas ópticas.
- Exige de toma de decisiones rápidas.
- Depende de la interdependencia de los miembros del equipo.
- Genera estrés en los intervinientes.

Sea cual sea el escenario, se debe hacer una planificación inicial, en la medida de lo posible. Esto es el *Briefing*. Se implementa antes de la situación de emergencia, y básicamente es la planificación inicial de la actuación, reparto de roles y recordatorio de instrucciones, procedimientos o protocolos. En definitiva, sería establecer una estrategia de abordaje del posible escenario, atendiendo a los protocolos estandarizados.

Sea cual sea la actuación del equipo sanitario, se puede facilitar la ventilación emocional de los profesionales expuestos para restablecer cierto confort. Esto es el *Defusing*. Se implementa tras la exposición a la situación crítica y requiere un entorno de seguridad y confianza. Básicamente, es la expresión libre de las emociones sentidas/vividas.

Y sea cual sea la actuación del equipo sanitario, se puede utilizar la experiencia vivida como una oportunidad de formación continua. Esto es el *Debriefing*. Se implementa después de la situación de emergencia y básicamente se trata de una reflexión posterior a la actuación del equipo sanitario, analizando los aspectos PLUS (acciones que se han implementado y que han resultado exitosas) y aspectos DELTA (acciones que podrían haberse desarrollado de otra forma para mejorar en rendimiento).

Para poder integrarlo de forma coherente y en las mejores condiciones posibles, queda estructurado siguiendo el modelo WHY/HOW/WHAT de Simon Sinek. En un primer momento analizamos por qué es necesario trabajar esta temática en nuestro medio (WHY). A continuación, desgranamos el cómo se implementa (HOW) y finalmente describimos qué herramientas y recursos son necesarios para que los profesionales de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia puedan utilizarlos en función de la necesidad y situación.

El propósito finalmente del presente documento, es facilitar a los equipos de urgencias y emergencias extrahospitalarias, 3 herramientas poderosas para permitir el desarrollo profesional y garantizar la seguridad del paciente.

1. WHY. POR QUÉ ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR BDD EN NUESTRO MEDIO

El principio fundamental que sustenta la pertinencia de estas herramientas es básicamente garantizar la seguridad del paciente, porque tenemos claro que, para alcanzar una asistencia sanitaria de excelencia, se precisa de un equipo sanitario alineado, engranado y efectivo.

Además, estas herramientas permiten:

- Poner foco y estructura antes de la actuación.
- Entrenar estrategias para crecer profesionalmente y abandonar el modelo “a salto de mata” y “siempre lo hemos hecho así”.
- Generar autocuidado dentro del equipo y garantizar el apoyo mutuo en situaciones complejas o traumáticas.
- Optimizar la respuesta en los equipos a través de la extracción de lecciones aprendidas tras cada exposición.
- Estandarizar formas de trabajar y protocolos asistenciales.

2. HOW. CÓMO IMPLEMENTAR LOS BDD EN NUESTRO MEDIO.

Existe una condición sine qua non imprescindible para poder implementar los BDD en nuestro medio. Se trata de la CON-FIAN-ZA.

La confianza es un concepto que a veces es mal entendido y puede llevar a confusión y para ello vamos a describir inicialmente lo que no es.

Disponer de confianza dentro del equipo sanitario de urgencias/emergencias extrahospitalarias NO ES:

- Ser amigos.
- Hacer concesiones.
- Evitar el conflicto.
- Hablar mucho y de forma superficial.

Y una vez que tenemos claro lo que NO es la confianza en nuestro medio, pasemos a describir cómo podemos construirla:

- Fomentando una comunicación abierta y honesta.
- Mostrando empatía y promoviendo el respeto.
- Ofreciendo feedback y reconocimiento mutuo.
- Asumiendo responsabilidad y admitiendo errores.
- Promoviendo la colaboración conjunta.
- Admitiendo los conflictos afrontándolos de forma constructiva.

Una vez que disponemos de un mínimo de confianza dentro del equipo, es el momento de plantearnos las herramientas BDD.

Para explicar el cómo implementar el BDD, vamos a utilizar el ejemplo de un intento autolítico de ingesta de pastillas en una adolescente de 16 años en su domicilio familiar.

BRIEFING	QUIÉN Y DÓNDE	El líder del equipo dirige el Briefing en la cabina de la ambulancia de camino al aviso
	CÓMO LO HACE	- Asegurar que existe un círculo de confianza suficiente - Dejar claro el propósito de la asistencia - Recordar la importancia de la seguridad del escenario y la colocación de los EPIS adecuados - Recordar los recursos existentes y anticipar situaciones donde habría que solicitar más recursos - Distribuir tareas (quién hace qué) - Refrescar algunos contenidos de interés (protocolos)
	Frases que se pueden utilizar	"ya sabéis que en las tentativas suicidas hay siempre mucha tensión en el ambiente y la familia va a estar muy pendiente de lo que decimos y cómo lo decimos" "os recuerdo que lo importante es asegurar la supervivencia física, pero no podemos dejar de lado el cómo lo hacemos" "ya sabéis que en estos casos tenemos que extremar la seguridad, y asegurarnos que la paciente no disponga de elementos lesivos cerca" "si os parece, vamos a hacer un repaso del material que vamos a necesitar" "vamos a repartir tareas elementales, aunque luego, la demanda exija re-estructurar el plan" "os recuerdo que el protocolo de primeros auxilios psicológicos dice que ……."

DEFUSING	QUIÉN Y DÓNDE	Cualquier miembro con habilidades socioemocionales, aunque con entrenamiento suficiente, no sería una actividad dirigida y se podría desarrollar de forma espontánea en la cabina de la ambulancia a la vuelta de la asistencia
	CÓMO LO HACE	- Asegurar que existe un círculo de confianza suficiente - Disponer de un entorno adecuado íntimo y sin interrupciones (cabina de la ambulancia) - Describir el propósito del Defusing - Recordar que este proceso exige confidencialidad por todas las partes (contrato de confidencialidad) - Recordar que las intervenciones deben ser libres (no coaccionadas) y que deben recoger el componente emocional de la experiencia vivida ("¿cómo os habéis sentido?") - Validar las emociones y reacciones del equipo. Esto es normalizar la situación, básicamente recordando que lo que estamos sintiendo es completamente normal, sin embargo, lo que no es "normal" es el evento que hemos experimentado - Agradecer a los integrantes, la participación en el grupo de Defusing
	Frases que se pueden utilizar	"ya sabéis que después de una intervención en una situación de crisis de calado psico-emocional es normal que algún compañero quiera compartir su experiencia, si estamos todos de acuerdo y nos encontramos cómodos podríamos implementar un Defusing" "el Defusing es el mejor medio para ventilar las emociones vividas y así, si aseguramos la confidencialidad de los relatos, podremos exponer y validar las emociones vividas" "ya sabeis que el Defusing es un procedimiento libre y que cada uno comparte lo que le apetezca, empezaré yo. En mi caso tengo que decir que al principio me ha impactado ver la escena porque tengo una hija de la misma edad y …, y vosotros ¿cómo os habéis sentido?" "os recuerdo que es completamente normal sentirnos de esta forma, lo que es atípico, no convencional y crítico es la situación acaecida" "gracias a todos por participar en este proceso, y ya sabéis, que si en los próximos días tenéis pensamientos recurrentes, o emociones encontradas u os sentís raros, tenéis que pedir ayuda"

DEBRIEFING	QUIÉN Y DÓNDE	Cualquier miembro con habilidades en el manejo del Debriefing y se puede desarrollar en la cabina de vuelta
	CÓMO LO HACE	- Asegurar que existe un círculo de confianza suficiente - Disponer de un entorno adecuado íntimo y sin interrupciones (cabina de la ambulancia) - Haber implementado un Defusing post intervención (“¿cómo os habéis sentido?”) si resulta necesario - Describir el propósito del Debriefing - Analizar los aspectos PLUS (acciones que se han implementado y que han resultado exitosas) - Analizar los aspectos DELTA (acciones que se han implementado y que podrían ser mejorables) - Resumir las lecciones aprendidas - Agradecer a los integrantes, la participación en el grupo de Debriefing - Difusión de lecciones aprendidas
	Frases que se pueden utilizar	“como bien sabéis, al ser un equipo con confianza suficiente, podemos aprovechar para aprender de cualquier experiencia y así crecer profesionalmente”. “¿qué acciones de todas las que hemos hecho han salido especialmente bien?, venga ¿quién empieza?” “¿qué acciones se podrían haber hecho de otra forma para optimizar tiempo, recursos o esfuerzo?, venga, empiezo yo…” “gracias por participar de este proceso de aprendizaje grupal y si os parece podemos compartir lo que hemos aprendido con el resto de nuestros compañeros”

3. WHAT. QUÉ HERRAMIENTAS Y RECURSOS SON NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS BDD EN NUESTRO MEDIO

Escucha activa. La escucha activa es eso, escuchar y sólo escuchar de forma activa, es decir, la persona debe entender que la estamos escuchando única y exclusivamente, de tal forma que nuestro contacto visual es adecuado, nuestra postura es de atención y desde luego no interrumpimos, ni damos nuestra opinión, ni préstamos atención a otro foco, por eso es tan importante elegir un lugar tranquilo, sin ruidos ni interrupciones.

No juicio. Es el pilar fundamental a la hora de crear un entorno psicológicamente seguro y básicamente se trata de no prejuzgar a ninguna persona o situación. Si algún miembro del equipo no es capaz de llevarlo a cabo, entonces, NO ES POSIBLE IMPLEMENTAR LA DBB. Esto es importantísimo, nunca implementar BDD, si no se puede asegurar un círculo de confianza.

Elección de un lugar tranquilo y sin interrupciones. Elegir una zona con poca estimulación ambiental y libre de perturbaciones nos asegura que la comunicación sea efectiva, y acelera la alianza entre los interlocutores. La cabina de la ambulancia a la vuelta de la asistencia puede ser una buena opción.

Ventilación emocional. La ventilación emocional es una forma adecuada de expresión de emociones de gran impacto y se aplica a personas que presentan cierta incapacidad de expresarlas de forma espontánea o libre. Se basa en generar una estructura de confianza donde la persona afectada no tenga temor a sentirse vulnerable o a ser juzgada y así de esta forma pueda ir reconociendo y expresando libremente las emociones que siente.

Contrato de confidencialidad. Es un contrato ficticio, no real de compromiso por todas las partes en el que se asume que toda la información que se va a compartir en el grupo se quedará ahí y que no

trascenderá a ningún otro escenario ni será tomada en cuenta en experiencias posteriores.

Normalizar la sintomatología. Se trata de explicar a los profesionales implicados, que los síntomas que experimenta (emocionales, cognitivos o fisiológicos) son completamente normales ante la excepcionalidad y anormalidad de lo que ha sucedido, es decir, que cualquier persona que estuviese en esa situación, experimentaría la misma sintomatología. Estas palabras suelen aliviar bastante porque la persona afectada siente que eso que le está pasando es algo extraño, inusual y de esta forma se reconoce que su cuerpo está reaccionando de forma normal ante un evento que no lo es.

Analizar aspectos PLUS. Se trata de identificar todas las acciones implementadas que han resultado exitosas (cuantas más, mejor) y analizar las consecuencias derivadas de esas acciones, es decir, hacer X ha generado Y (ahorrar tiempo, esfuerzo o recursos).

Analizar aspectos DELTA. Se trata de identificar todas las acciones que se han implementado y que podrían ser mejorables, es decir, que con el conocimiento de la experiencia actual, se podrían haber hecho de otra forma para ahorrar tiempo, esfuerzo o recursos. Se puede iniciar desde la autorreflexión, de tal forma que podemos examinar las propias acciones y ver si son mejorables. A continuación, se pueden identificar aspectos DELTA en los compañeros, y esto exige de cierta asertividad, por ejemplo, se puede decir “Compañero X, me he dado cuenta que para el lavado gástrico has utilizado un suero no caliente y la temperatura ambiental es muy baja, me pregunto ¿qué ha pasado?

Difusión de lecciones aprendidas. Se trata de sintetizar todos los aprendizajes obtenidos del debriefing; los PLUS y las lecciones aprendidas de los DELTA y compartirlos con los compañeros de la base y/o escribirlos en un repositorio en el que se pueda ser consultado por los sustitutos o a posteriori por todos.